Lombalgie commune

Radiographie du rachis lombaire · adulte

Sans drapeau rouge, une poussée aiguë de lombalgie ne justifie aucune imagerie, et la radiographie isolée n'est indiquée que pour rechercher une instabilité ou un trouble statique.[1]

1. Urgence ? Sciatique hyperalgique rebelle aux opiacés · sciatique paralysante (déficit moteur < 3 MRC ou progressif) · syndrome de la queue de cheval → **examen en urgence et/ou avis spécialisé** : contacter le radiologue ou le spécialiste.[2]

2. Drapeaux rouges (HAS 2019)[1]

Douleur et neurologie

- Douleur non mécanique (progressive, au repos, nocturne)
- Symptôme neurologique étendu (sphincters, motricité des jambes)
- Paresthésies du pubis ou du périnée
- Rachialgies dorsales
- Déformation structurale importante

Terrain et contexte

- Traumatisme important (chute de hauteur)
- Début avant 20 ans ou après 55 ans
- Antécédent de cancer
- Drogue IV ou corticoïdes au long cours

Signes généraux

- Fièvre, syndrome fébrile
- Altération de l'état général
- Perte de poids inexpliquée

Drapeau rouge → plus une lombalgie commune : **imagerie justifiée**, examen adapté à la pathologie suspectée (avec le radiologue). C'est la combinaison des signes qui doit alerter.[1]

3. Sans drapeau rouge[1]

Poussée aiguë, avec ou sans radiculalgie	**PAS D'IMAGERIE** grade C · revoir à 2–4 semaines
Douleur persistante malgré le traitement, moins de 3 mois	**Pas de radio** réévaluer, rechercher les drapeaux rouges
Lombalgie chronique (plus de 3 mois)	**IRM** scanner si contre-indication
Geste invasif envisagé (infiltration épidurale, voire chirurgie)	**IRM** sauf patient hyperalgique
Recherche d'une **instabilité*** : mobilité anormale entre deux vertèbres (ex. spondylolisthésis : est-il mobile ?)	**RADIOS DYNAMIQUES** profils en flexion et extension
Recherche d'un **trouble statique*** : défaut d'alignement global (scoliose, équilibre sagittal)	**RADIOS EN CHARGE** grand format ou EOS
Imagerie déjà faite, symptômes inchangés	**Pas de nouvelle imagerie**

* Précision d'usage, non définie par la HAS. Seuils d'instabilité les plus cités sur les profils dynamiques : translation > 3 à 5 mm ou variation d'angulation > 10°, non consensuels. À demander surtout si le résultat peut changer la prise en charge (bilan avant chirurgie).[3]

Contenu clinique repris de la fiche HAS 2019 (lombalgie commune) et de la fiche pertinence FNMR pour les urgences. Ne remplace pas le jugement clinique. Le radiologue peut adapter l'examen demandé au contexte clinique.

1. HAS – Prise en charge du patient présentant une lombalgie commune (2019) : https://www.has-sante.fr/jcms/c_2961499/fr/prise-en-charge-du-patient-presentant-une-lombalgie-commune
2. FNMR – Pertinence en imagerie médicale : https://fnmr.fr/pertinence-en-imagerie-medicale/
3. Radiopaedia – Degenerative spinal instability : https://radiopaedia.org/articles/degenerative-spinal-instability

Crâne, sinus, massif facial

Radiographie standard

La radiographie du crâne, des sinus et du massif facial n'est pas indiquée, sauf exception. Si une imagerie est nécessaire : TDM ou IRM.[1]

Radio du crâne

Pas d'indication en règle générale.
Si une imagerie est nécessaire : **TDM ou IRM**.[1]

Selon la HAS (octobre 2008), les indications restantes sont « exceptionnelles » et appelées à évoluer : en 2018, la plupart doivent être remplacées par une imagerie en coupe.[1]

Indications restantes (HAS 2008)
Maltraitance suspectée chez l'enfant
Myélome
Tumeur osseuse primitive
Recherche de métastases osseuses
Maladies osseuses métaboliques
Maladie de Paget
Ostéomalacie
Ostéomyélite

Radio des sinus et du massif facial

Pas d'indication, sauf exception.
Si une imagerie est nécessaire : **TDM ou IRM**.[1]

Une seule indication
Dépistage d'un corps étranger intra-orbitaire : incidence de profil, complétée si nécessaire par une incidence de face.[1]

Arbre décisionnel

Corps étranger intra-orbitaire à dépister ?
- Radio des orbites

OUI → **Profil** ± face

Crâne : une des 8 indications restantes ?
- Maltraitance de l'enfant, myélome, tumeur osseuse primitive, métastases
- Maladie osseuse métabolique, Paget, ostéomalacie, ostéomyélite

OUI → **Radio possible** imagerie en coupe souvent préférable

Autre situation → **PAS DE RADIOGRAPHIE** · si imagerie nécessaire : TDM ou IRM

Contenu clinique repris des fiches pertinence FNMR (recommandations HAS / SFR). Ne remplace pas le jugement clinique. Situations hors fiche : ADERIM (SFR). Le radiologue peut adapter l'examen demandé au contexte clinique.

1. FNMR – Pertinence en imagerie médicale : https://fnmr.fr/pertinence-en-imagerie-medicale/

Thorax

Radiographie standard du thorax

De nombreux contextes cliniques ne justifient pas la radio du thorax, soit parce que l'imagerie est inutile, soit parce qu'ils nécessitent une autre technique.[1]

Non-indications de la radiographie du thorax[1]

Contexte	La radio du thorax n'est pas indiquée
Urgences	• Admission sans trouble cardio-pulmonaire aigu • Suspicion de perforation œsophagienne • Suspicion de dissection aiguë de l'aorte thoracique • Suspicion de rupture d'anévrisme de l'aorte thoracique
Réanimation	• Suivi d'un patient stable et ventilé • Suivi à distance de la position d'un matériel implanté
Pré-opératoire	• Chirurgie non cardiothoracique chez un sujet de moins de 60 ans, sans pathologie cardio-vasculaire ou avec une pathologie stable
Cardio-vasculaire (hors péri-opératoire)	• HTA • Suivi d'une insuffisance cardiaque congestive chronique ou d'une cardiomyopathie
Respiratoire non tumoral	• Infection des voies aériennes hautes • Bronchite aiguë • Bronchiolite de l'enfant (1er épisode non compliqué) • Douleur thoracique non spécifique hors urgence
Respiratoire tumoral	• Dépistage du cancer bronchique • Dépistage du mésothéliome

Hors de ces situations, l'utilité de la radiographie standard du thorax a été démontrée dans de multiples situations cliniques.[1]

Certains contextes nécessitent une autre technique : **TDM, IRM, échographie-doppler...** Le détail des rares indications restantes figure dans le rapport complet de la HAS.[1]

Contenu clinique repris des fiches pertinence FNMR (recommandations HAS / SFR). Ne remplace pas le jugement clinique. Situations hors fiche : ADERIM (SFR). Le radiologue peut adapter l'examen demandé au contexte clinique.

1. FNMR – Pertinence en imagerie médicale : https://fnmr.fr/pertinence-en-imagerie-medicale/

Abdomen sans préparation (ASP)

Adulte et enfant

L'ASP est très rarement indiqué, chez l'adulte comme chez l'enfant.[1]

Adulte : ASP très rarement indiqué.
Le plus souvent remplacé par **échographie et/ou TDM**.[1]

Enfant : ASP très rarement indiqué.
Le plus souvent : **échographie**.[1]

Indications restantes : adulte et enfant[1]

	Adulte	Enfant
Alternative	Échographie et/ou TDM, si une imagerie est justifiée	Échographie le plus souvent ; l'ASP complète parfois une échographie non contributive
Colectasie	Colite aiguë grave dans la maladie de Crohn et la RCH	Suspicion de colectasie (MICI)
Corps étranger	Surtout si acéré ou potentiellement toxique	Surtout si acéré ou potentiellement toxique
Lithiase rénale	Suivi de colique néphrétique · exploration péri-opératoire (écho et TDM : alternatives selon taille et localisation)	En cas d'échographie non contributive
Douleurs abdominales	—	Échographie non contributive · suspicion d'occlusion · suspicion de perforation
Spécifique	Recherche de stérilet non visible en échographie	Nouveau-né : suspicion d'entérocolite Masse abdominale : calcifications après échographie (inutile si une TDM est envisagée)

Hors de ces indications → **PAS D'ASP** · proposer l'échographie (± TDM chez l'adulte)

Contenu clinique repris des fiches pertinence FNMR (recommandations HAS / SFR). Ne remplace pas le jugement clinique. Situations hors fiche : ADERIM (SFR). Le radiologue peut adapter l'examen demandé au contexte clinique.

1. FNMR – Pertinence en imagerie médicale : https://fnmr.fr/pertinence-en-imagerie-medicale/

Genou : radio avant IRM

Adulte · gonalgie non traumatique et post-traumatique

Chez l'adulte : radiographies en 1re intention, pas d'IRM en 1re intention, avec ou sans traumatisme.[1,2]

Urgence – arthrite septique suspectée : ponction articulaire diagnostique (et hémocultures) en urgence, avant toute antibiothérapie ; prise en charge spécialisée. L'imagerie ne doit pas la retarder.[1]

Urgence absolue – luxation fémoro-tibiale (choc violent) : hospitalisation, avis chirurgical et angioscanner au plus vite.[2]

Gonalgie non traumatique[1]

1er épisode ou épisode inhabituel	**RADIOS** pas d'IRM
Nouvel épisode, pathologie connue, symptômes habituels	**Pas de nouvelle imagerie**
Radios : arthrose typique, > 40 ans, évolution typique	**Pas d'autre imagerie**
Arthrose + présentation atypique, aggravation rapide inattendue ou changement clinique	**IRM**
Radios ± écho normales ou n'expliquant pas les symptômes, douleur persistante	**IRM** après réévaluation · penser douleur projetée
Radios : autre atteinte osseuse / parties molles / articulaire	**TDM et/ou IRM · écho et/ou IRM · IRM** à discuter
Radios : image tumorale agressive, atypique ou indéterminée	**Centre spécialisé**

Après un traumatisme[2]

Règle d'Ottawa – radios si au moins un critère :

- Âge ≥ 55 ans
- Douleur isolée de la patella
- Douleur de la tête de la fibula
- Incapacité de flexion à 90°
- Incapacité de mise en charge sur 4 pas

À discuter aussi : point douloureux osseux autre, plaie à risque septique.

Aucun critère	**Pas de radio** réévaluation clinique
Radios : fracture	**Avis chirurgical** imagerie en coupe à discuter
Radios normales + suspicion de fracture occulte	**Scanner < 48 h**
Radios normales + blocage vrai (anse de seau)	**Avis chirurgical**
Radios normales + lésion ménisco-ligamentaire suspectée	**IRM à distance** si elle conditionne la PEC
À distance, aucune radio réalisée	**Commencer par les RADIOS**

Incidences (1er bilan, non traumatique) : face et profil en charge au minimum · défilé fémoro-patellaire 30° si atteinte fémoro-patellaire suspectée · Schuss si arthrose fémoro-tibiale suspectée · clichés bilatéraux.[1] | 61 % des patients ayant eu une IRM du membre inférieur n'avaient pas eu la radiographie préalable recommandée.[3]

Contenu clinique repris des fiches HAS / CNP G4 de juin 2022 (adulte uniquement). Ne remplace pas le jugement clinique. Le radiologue peut adapter l'examen demandé au contexte clinique.

1. HAS – Gonalgie non traumatique de l'adulte (2022) : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-06/app_445_fiche_imagerie_gonalgie_non_trauma_mel_2022-06-24_12-03-4_460.pdf
2. HAS – Gonalgie après traumatisme du genou (2022) : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-06/app_445_fiche_imagerie_gonalgie_post_trauma_mel.pdf
3. HAS – État des pratiques IRM du membre inférieur (2023) : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-09/has-103_rapport_irm_membre_inferieur_cd_2023-05-17_vd.pdf